

3 気管支・細気管支の疾患 bronchus, bronchiole disease

A 気管支拡張症 bronchiectasis

到達目標

- 気管支拡張症の病態について説明できる
- 気管支拡張症の診断ができる
- 気管支拡張症における各種検査を理解できる
- 気管支拡張症の管理・治療方針が決定できる

定義, 病態, 疫学

気管支拡張症とは気管支が何らかの原因によって不可逆性の拡張をきたした症候群である。気管支拡張症の分類は過去には気管支拡張の形態学的な分類がなされていたが、現在では病因による分類がされている（表1）。わが国で多いのは、びまん性汎細気管支炎（diffuse panbronchiolitis : DPB）を含めた副鼻腔気管支症候群（sinobronchial syndrome : SBS）である。また気管支拡張症は副鼻腔炎との関連が知られており、遺伝性、先天性ではほぼ100%関連するとされ、閉塞性以外の病態では約半数の症例が副鼻腔異常と関連¹⁾

表1 気管支拡張症の原因と副鼻腔炎

障害	疾患例	副鼻腔炎の頻度
特発性		45~84%
先天性	DPB, SBS PCD CF Young 症候群	ほぼ100%
免疫不全	HIV common variable hypogammaglobulinemia	ほぼ100%
感染後	結核 非結核性抗酸菌症 麻疹 百日咳	50%
免疫過剰反応	ABPA GVHD 炎症性腸疾患	40~90% 気管支拡張の程度による
機械的閉塞	腫瘍 異物 リンパ節腫脹	まれ

DPB : diffuse panbronchiolitis

SBS : sinobronchial syndrome

PCD : primary ciliary dyskinesia

CF : cystic fibrosis

HIV : human immunodeficiency virus

ABPA : allergic bronchopulmonary aspergillosis

GVHD : graft-versus-host disease

[Loebinger MR, et al : Thorax 64 : 1096, 2009 より作成]

するとされる。

気管支拡張症の正確な疫学は明らかではないが、加齢とともに増加する²⁾ことが示されている。近年では、小児期の呼吸器感染症のコントロールとともに気管支拡張症は減少傾向にあるとされる。

症状, 身体所見

慢性咳嗽、喀痰、血痰、咯血、呼吸困難などが主な症状である。進行した気管支拡張症では下気道慢性感染にて湿性咳嗽を呈する。病態が進行すると低酸素血症による肺高血圧や右心不全を生じる。呼吸不全はⅡ型を呈することが多く、CO₂ナルコーシスに留意する。

聴診では気管支拡張部位に一致して coarse crackles を聴取する。また気道分泌物のある症例では squeak や squawk などのラ音を聴取する。

診断・検査

気管支拡張症の診断は HRCT で行う。気管支拡張の CT 所見³⁾としては、気管支壁の肥厚、気管支径減少の消失、随伴する血管径より気管支径の増大（signet ring sign）、胸膜直下1 cm 以内での気管支がみら

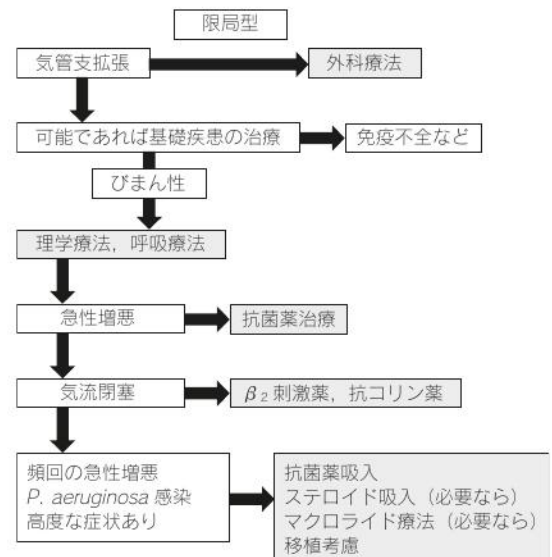


図1 気管支拡張症における治療フローチャート

[Rademacher J, et al : Dtsch Arztebl Int 108 : 809, 2011 より作成]